

רעלת היריון וקדם־רעלת היריון (Pre-Eclampsia, Eclampsia)

רעלת היריון (pre-eclampsia או pre-eclampsia toxemia: PET) היא מצב רפואי המתרחש ב־5% עד 7% מההריונות ומאופיין בשלושה תסמינים: עליית לחץ דם, פרוטאינוריה (proteinuria, עלייה בכמות החלבון בשתן) ובצקת. משום ששכיחות הבצקות גבוהה גם בהריונות נורמליים, הימצאות של בצקת כשלעצמה אינה קריטריון לאבחון רעלת היריון. רעלת היריון היא מצב רפואי פתולוגי הכרוך בסיכון לתחלואה ואף לתמותה של האישה. תרופות להורדת לחץ דם משמשות רק לטיפול בתסמינים ולא במחלה עצמה, יילוד העובר הוא הדרך היחידה שבה אפשר לסיים את רעלת היריון.

מאפייני רעלת היריון

- מתחילה בדרך כלל לאחר השבוע ה-20 להיריון.
- הגורם לא ידוע, יתר לחץ דם (יל"ד) וסוכרת הם גורמים מסייעים למחלה.
- המחלה גורמת לאי־סדירות במחזור הדם של האישה.
- הבעיה משפיעה על זרימת הדם לכליות. הן אוגרות נתרן כפיצוי, וגורמת לכיווץ של כלי הדם הפריפריים.
- הנזק לעובר: כיווץ כלי הדם הפריפריים גורם לנזק באספקת הדם לתינוק.
- התוצאה: האטה בגדילת העובר או מותו.
- תלונות האישה: כאבי ראש, טשטוש ראייה וכאבי בטן.
- בבדיקה: בצקות ולחץ דם גבוה.
- כל לחץ דם מעל 130/80 מ"מ כ" או עלייה בדיאסטולי מעל 15 מ"מ כ" יותר מהרגיל צריך להחשיד לקיום המחלה.

רעלת, אקלמפסיה (Eclampsia)

אקלמפסיה (eclampsia) היא התפרצות מלאה של תופעות כגון פרכוסים אצל אישה עם רעלת היריון (pre-eclampsia).

- קדם רעלת יכולה להתפתח לרעלת לפני, תוך כדי ואחרי הלידה
- המחלה גורמת לתמותה של 5%-15% מהנשים
- זהו הגורם השני בחומרתו למות האם
- התלונות: כאבי ראש, טשטוש ראייה וכאבי בטן.
- הסימנים: בצקות (בעיקר בפנים ובידיים), לחץ דם גבוה, חיוורון ופחד. כמו כן רואים פרכוסים אפילפטיים.

הטיפול

הטיפול הוא בעיקר דיכוי הפרכוסים במהירות.

- שומרים על בטיחותה של המטופלת
- מאבטחים A, B ומספקים חמצן
- מתחילים פינוי לבית חולים קרוב ומדווחים על אבחנה משוערת
- חוברים לנט"ן בהתייעצות עם מוקד מרחבי

- משכיבים את המטופלת על צידה השמאלי
- מנטרים סימנים חיוניים לאורך כל הטיפול והפינוי

לחץ דם נמוך בשכיבה

כשהאישה מתקרבת לסוף ההיריון היא נושאת משקל כבד הכולל את משקל הרחם, העובר והשליה. משקל זה, כשהאישה שוכבת על גבה, לוחץ על הווריד הנבוב התחתון ומונע חזרה ורידית תקינה ללב.

התוצאה: ירידה של 30%-40% מתפוקת הלב.

- נפח כלי הדם הוא מלכתחילה גבולי ויש להיזהר, לכן בכל מקרה של השכבת האישה לצורך בדיקה או פינוי יש להשכיבה על צידה השמאלי כי ה־vena cava נמצא בצד ימין.
- אם לחץ הדם ממשיך לרדת יש חשד להלם ויש להמשיך טיפול כנדרש.

סוכרת היריון

אישה הרה שמאובחנת כסוכרתית בדרך כלל משתייכת לאנשים עם סוכרת סמויה, כלומר הייתה לה סוכרת לפני ההיריון או התפתחה במהלכו.

- הסוכרת בדרך כלל אינה מתגלה בבדיקת שתן.
- סוכרת היריון עלולה לגרום לפגיעה ולמומים ביילוד.
- לעובר מערכת איזון סוכר משלו, אך את הסוכר הוא מקבל מהאם; מכאן שאם לאם יש סוכרת אין פירוש הדבר שלעובר תהיה סוכרת.
- אצל נשים חולות סוכרת בדרך כלל מתפתחים ולדות גדולים מהרגיל (מעל 4.5 ק"ג), ולכן במקרים מסוימים מקדימים את הלידה סמוך לשבוע ה־36.
- לתינוקות אלה, למרות גודלם, יש בדרך כלל מאפיינים של פג.
- תופעה שכיחה אצל תינוקות אלה היא שמייד לאחר הלידה מתפתחת אצלם היפוגליקמיה, העלולה להימשך 24-72 שעות, והיא חולפת בהדרגה. יש למנוע היפוגליקמיה על ידי מעקב ומתן גלוקוז.
- על האישה לשמור על איזון הסוכר בדמה ולהשתדל לא להיות עם רמת סוכר גבוהה.

לידה

סוגי לידות

- (1) היריון במועד - היריון המסתיים בשבועות 37-42
- (2) לידה - יציאה שלמה של עובר שמשקלו 500 גרם ויותר או תינוק עם סימני חיים
- (3) לידה מוקדמת - לידה לפני תום שבוע 37 להיריון
- (4) פג - תינוק שנולד לפני תום השבוע ה־37 להיריון